

Melasma

1. Introducción y relevancia clínica

El **melasma** es una **hipermelanosis adquirida y simétrica** que afecta principalmente la **cara**, caracterizada por **máculas hiperpigmentadas** de tonalidad marrón, sin descamación ni relieve.

Es una de las causas más frecuentes de consulta dermatológica en mujeres jóvenes y de mediana edad.

Relevancia clínica

- Afecta entre el **1,5 y 5% de la población**, predominando en **fototipos III–V** (latinos, asiáticos y mestizos).
 - Se asocia fuertemente con **exposición solar crónica** y **cambios hormonales** (embarazo, anticonceptivos orales, terapia hormonal).
 - No tiene implicancia sistémica, pero genera **alteración estética significativa y afectación emocional**.
 - En el contexto EUNACOM, suele evaluarse su **fisiopatología, diagnóstico diferencial con otras hiperpigmentaciones, y tratamiento basado en fotoprotección y terapia despigmentante**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismos fisiopatológicos

El melasma se produce por un **aumento de la actividad melanocítica** (no del número de melanocitos), lo que genera **exceso de melanina** en epidermis y/o dermis.

Los principales mecanismos involucrados son:

1. **Estimulación hormonal:**
 - Estrógenos y progesterona aumentan la síntesis de melanina mediante la activación de la **tirosinasa**, enzima clave en la melanogénesis.

- Esto explica su aparición durante el **embarazo** (“cloasma gravídico”) o con **anticonceptivos hormonales**.

2. Radiación ultravioleta (UV) e infrarroja:

- La exposición solar crónica induce liberación de **α -MSH**, **endotelina-1** y **factor de crecimiento de fibroblastos (FGF)**, que estimulan la melanogénesis.
- También produce daño dérmico y oxidativo.

3. Predisposición genética:

- Hasta 40% de los pacientes tienen antecedentes familiares de melasma.
- Se han identificado polimorfismos en genes de la tirosinasa y receptores de estrógenos.

4. Inflamación dérmica crónica:

- Aumenta la permeabilidad vascular y el depósito de melanina en macrófagos dérmicos (**melanófagos**).

2.2. Factores predisponentes

Grupo	Ejemplos
Hormonales	Embarazo, ACO, terapia de reemplazo hormonal
Físicos	Exposición solar, radiación UVA/UVB, calor
Químicos	Perfumes, cosméticos, fármacos fotosensibilizantes (fenitoína, tetraciclinas)
Genéticos	Antecedentes familiares

Raciales Fototipos III–V (piel morena o mestiza)

2.3. Clasificación histológica

Tipo	Localización del pigmento	Características
Epidérmico	Aumento de melanina en capa basal y suprabasal	Responde bien a tratamientos tópicos
Dérmico	Melanófagos en dermis papilar	Respuesta lenta y parcial
Mixto	Combinación de ambos	El más frecuente (≈70%)

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Presentación clínica

Lesiones

- **Máculas hiperpigmentadas** color marrón claro a oscuro, de bordes irregulares pero bien definidos.
- **Asintomáticas**, sin relieve ni descamación.
- De evolución crónica y recurrente, especialmente en verano.

Distribución facial típica

1. **Centrofacial (más frecuente, 60%)**
 - Frente, mejillas, labio superior, nariz y mentón.
2. **Malar (30%)**

- Mejillas y nariz.

3. Mandibular (10%)

- Línea mandibular y cuello.

Otros sitios posibles

- Cuello, antebrazos, tórax superior (melasma extrafacial, más raro).

3.2. Evolución clínica

- Curso **crónico y recidivante**, con exacerbaciones en verano y mejora en invierno.
- Empeora con exposición solar, calor, embarazo o anticonceptivos hormonales.
- Sin tratamiento, tiende a persistir durante años.

3.3. Diagnóstico diferencial

Enfermedad	Características diferenciales
Lentigos solares	Máculas hiperpigmentadas aisladas, en áreas fotoexpuestas, en adultos mayores
Eférides (pecas)	Pequeñas máculas desde la infancia, que se aclaran en invierno
Pigmentación postinflamatoria	Antecedente de acné, eczema o trauma local
Dermatosis cenicienta	Pigmentación gris-azulada difusa, frecuente en fototipos altos

Ocronosis exógena

Pigmentación azul-negrúzca por abuso de hidroquinona tópica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico** y se basa en:

1. Máculas hiperpigmentadas simétricas en zonas fotoexpuestas.
2. Antecedentes de exposición solar u hormonal.
3. Curso crónico y recidivante.
4. Ausencia de descamación o síntomas inflamatorios.

4.2. Luz de Wood

Permite diferenciar el tipo de pigmentación:

- **Epidérmico:** pigmento marrón que se intensifica bajo luz de Wood.
- **Dérmico:** pigmento gris-azulado que no cambia de color.
- **Mixto:** áreas con ambos patrones.

4.3. Exámenes complementarios

- Generalmente no son necesarios.
- En casos atípicos o resistentes:
 - **Biopsia cutánea:** confirma depósito epidérmico o dérmico de melanina.
 - **Perfil hormonal:** si sospecha de alteración endocrina.

4.4. Criterios diagnósticos (AAD, 2024)

1. Máculas hiperpigmentadas simétricas en zonas fotoexpuestas.
2. Ausencia de descamación o signos inflamatorios.
3. Luz de Wood que confirma pigmento epidérmico, dérmico o mixto.
4. Historia de exposición solar o hormonal.

Diagnóstico confirmado: criterios 1 + 2 + 3.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile, 2023)

El objetivo terapéutico es **reducir la pigmentación, prevenir recurrencias y evitar efectos adversos**.

El tratamiento debe ser **prolongado (≥6 meses)** y acompañado de **fotoprotección rigurosa**.

5.1. Medidas generales

1. **Fotoprotección:**
 - FPS $\geq$ 50, amplio espectro (UVA/UVB/luz visible).
 - Aplicar cada 2–3 horas durante el día.
 - Uso diario incluso en interiores y días nublados.
2. **Evitar desencadenantes:**
 - Suspender anticonceptivos orales si es posible.
 - Evitar perfumes o cosméticos fotosensibilizantes.
 - Protegerse del calor y radiación infrarroja.
3. **Apoyo psicológico:** el melasma impacta la autoestima y la calidad de vida, especialmente en mujeres jóvenes.

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Tópico (primera línea)

1. Hidroquinona (HQ) 2–4%

- Inhibe la tirosinasa y reduce la síntesis de melanina.
- Aplicar 1 vez/día por la noche durante 8–12 semanas.
- Efectos adversos: irritación, eritema, **ocronosis exógena** si uso prolongado (>6 meses).

2. Triple combinación (Kligman modificado)

- **Hidroquinona 4% + tretinoína 0,05% + fluocinolona 0,01%.**
- Sinergia despigmentante + antiinflamatoria.
- Eficaz en melasma epidérmico y mixto.
- Uso nocturno por ciclos de 8–12 semanas, con descanso terapéutico.

3. Alternativas sin hidroquinona:

- **Ácido azelaico 20%:** inhibe la tirosinasa; seguro en embarazadas.
- **Niacinamida 4–5%:** reduce transferencia de melanina a queratinocitos.
- **Kojic acid, arbutina, ácido tranexámico tópico.**
- Menos irritantes, pero requieren uso prolongado.

B. Sistémico (segunda línea o refractario)

Fármaco

Mecanismo

Evidencia

Ácido tranexámico oral (250 mg cada 12 h por 3 meses)	Inhibe plasmina → reduce melanogénesis inducida por UV	Buena respuesta, recurrencia frecuente al suspender
Antioxidantes (vitamina C, polipodium leucotomos)	Reducción de estrés oxidativo	Adyuvante
Corticoides sistémicos	No indicados	Riesgo > beneficio

C. Procedimientos dermatológicos (tercera línea)

Procedimiento	Indicaciones	Comentarios
Peelings químicos (ácido glicólico, salicílico)	Melasma epidérmico leve	Riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria
Láser fraccionado / luz pulsada	Casos refractarios	Solo en centros especializados
Microneedling + tranexámico tópico	Alternativa moderna	Mejora la penetración cutánea

MINSAL y AAD recomiendan que los procedimientos se reserven para pacientes refractarios al tratamiento médico y siempre combinados con fotoprotección.

5.3. Manejo integral según tipo de pigmento

Tipo	Tratamiento recomendado
Epidérmico	Hidroquinona o triple combinación + fotoprotección

Dérmico Ácido tranexámico oral o láser no ablativo

Mixto Combinación de tópicos + fototerapia o peeling suave

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Hiperpigmentación postinflamatoria	Por irritación excesiva o peeling inadecuado
Ocronosis exógena	Uso prolongado de hidroquinona (>6 meses)
Recurrencia	Frecuente al suspender tratamiento o descuidar fotoprotección
Dermatitis de contacto	Irritación por tretinoína o HQ
Impacto psicológico	Ansiedad, frustración, baja autoestima

Pronóstico:

- En general, **crónico y recidivante**, con mejoría parcial.
 - La repigmentación total es rara.
 - La clave está en el **control continuo y la prevención de recaídas** mediante fotoprotección diaria.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Melasma** = máculas marrones simétricas en zonas fotoexpuestas, sin descamación ni relieve.
 2. **Empeora con sol, calor y hormonas (embarazo o ACO).**
 3. **Fotoprotección diaria** es el pilar del tratamiento, incluso sin exposición solar directa.
 4. **Triple combinación (HQ + tretinoína + corticoide)** es el esquema más efectivo en la práctica clínica.
 5. **Luz de Wood** ayuda a diferenciar tipo epidérmico (responde mejor) vs dérmico (responde peor).
 6. **Ácido tranexámico oral** es útil en casos refractarios (uso por dermatólogo).
 7. En **EUNACOM**, la clave está en reconocer que **el melasma no descama, es simétrico y aparece en mujeres en edad fértil con exposición solar.**
-



Errores comunes

- No usar fotoprotección constante o interrumpirla en invierno.
 - Uso prolongado de hidroquinona sin control → ocronosis.
 - Diagnosticar como hiperpigmentación postinflamatoria o lentigo solar.
 - Indicar corticoides orales o tópicos prolongados en monoterapia.
 - No advertir que el melasma **no se cura**, solo se controla.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **melasma** es una **hipermelanosis adquirida y simétrica** del rostro, inducida por **sol y hormonas**.
2. La **luz de Wood** permite distinguir si la pigmentación es **epidérmica, dérmica o mixta**.
3. El **tratamiento base** es la **fotoprotección rigurosa (FPS $\geq$ 50)**.
4. Los **tópicos despigmentantes (hidroquinona, ácido azelaico, triple combinación)** son la primera línea.
5. El **ácido tranexámico oral** y los **procedimientos dermatológicos** son opciones para casos refractarios.
6. Es una enfermedad **crónica y recidivante**, con respuesta variable y necesidad de mantenimiento.
7. En **EUNACOM**, la clave diagnóstica es: **mujer joven con máculas marrones simétricas faciales, sin descamación, desencadenadas por sol o embarazo**.